

ANAMNESI

(Raccolta dal Dott. Aragorn Elessar, Medico Specializzando in Ortopedia, III anno, e controfirmata dal Dott. E. Peredhel in data 27/10/2025 ore 15:15)

Allergie Note:

- **Farmaci:**
 - Acido Acetilsalicilico (Aspirina) → Riferita reazione orticarioide severa (eruzione cutanea pruriginosa diffusa, richiese trattamento con antistaminici) circa 20 anni fa (anno 2005 circa). Da allora evitato scrupolosamente. Tollerati altri FANS (Ibuprofene, con lieve pirosi gastrica occasionale).
 - Nega allergie a Paracetamolo, Antibiotici (riferisce assunzione in passato di Amoxicillina per tonsillite senza reazioni), Anestetici locali.
- **Alimenti:**
 - Lembas (alimento elfico tradizionale) → Riferita reazione cutanea con rash pruriginoso al tronco in due occasioni (ultima volta circa 5 anni fa). Da allora evitato.
- **Inalanti:**
 - Pollini di Mallorn → Rinite allergica stagionale (primavera, mesi marzo-maggio), controllata con antistaminico (Cetirizina 10mg) al bisogno. Non asma bronchiale.
- **Altro:**
 - Negativo per allergie a lattice (verificato in anamnesi - ha fatto precedenti visite specialistiche con guanti in lattice senza reazioni)
 - Negativo per allergie a metalli (porta orecchini in oro da sempre)
 - Negativo per allergie a mezzi di contrasto iodati (eseguita TC con mdc circa 6 anni fa senza reazioni)

Anamnesi Patologica Remota (APR):

- **Cardiovascolare:**

Ipercolesterolemia familiare diagnosticata circa 12 anni fa (anno 2013), con valori massimi di Colesterolo Totale 268 mg/dL e LDL 180 mg/dL. In trattamento con statine da allora (inizialmente Atorvastatina 10mg, poi passata a Rosuvastatina 5mg per migliore tollerabilità). Attuale controllo: Colesterolo Totale 225 mg/dL, LDL 140 mg/dL (ultimo controllo Settembre 2025).

Circa 2 anni fa (Novembre 2023) riscontro occasionale di soffio carotideo sinistro all'auscultazione durante visita dal MMG. Eseguito Eco-Color-Doppler TSA (vedi Sezione 6) con evidenza di carotidopatia aterosclerotica con stenosi 30% carotide interna sinistra, placca fibro-calcifica non ulcerata, asintomatica (nessun TIA, nessun deficit neurologico). Per tale motivo, dopo consulenza neurologica e angiologica, iniziata terapia con Clopidogrel 75mg/die (da Dicembre 2023). In follow-up angiologico semestrale (prossimo controllo previsto Maggio 2026).

Nega ipertensione arteriosa. Valori abituali domiciliari: 125-135/75-80 mmHg (misurazione occasionale dal MMG e automisurazione sporadica).

Nega cardiopatia ischemica, aritmie note, scompenso cardiaco.

ECG del 2023 (in occasione del riscontro del soffio carotideo): nei limiti.

- **Ematologica:**

Riscontro occasionale circa 1 anno fa (Giugno 2024) di lieve piastrinosi persistente (PLT 410.000-430.000/ μ L) in esami di routine richiesti dal MMG. Inviata a visita ematologica (Dott.ssa Tauriel - vedi Sezione 6, referto). Eseguiti accertamenti approfonditi: JAK2 V617F negativo, BCR-ABL negativo, assenza di splenomegalia all'ecografia addome. Conclusione: piastrinosi reattiva secondaria, verosimilmente legata a stato flogistico cronico di basso grado (contribuiscono: carotidopatia, scoliosi degenerativa, enfisema). Giudicata non a rischio trombotico. Non indicazione a terapia citoriduttiva. In follow-up semestrale con emocromo presso MMG.

- **Pneumologica:**

Diagnosticato enfisema polmonare panlobulare di grado lieve circa 5 anni fa (anno 2020) nel corso di accertamenti per dispnea da sforzo progressiva. Eseguita TC Torace HRCT (vedi Sezione 6) che ha documentato enfisema diffuso, prevalente ai lobi superiori. Non fumatore attivo né pregresso (mai fumato erba pipa o tabacco in vita). Riferisce possibile esposizione passiva in gioventù (padre fumatore). Spirometria (anno 2020): lieve ostruzione (FEV1 72% del predetto, rapporto FEV1/FVC 65%). Non ossigeno-terapia domiciliare. Riferisce dispnea solo per sforzi intensi e prolungati (es. salire 2 rampe di scale di corsa, camminate in salita ripida), non limitante le attività della vita quotidiana abituale. Non tosse cronica produttiva, non bronchiti ricorrenti, non riacutizzazioni negli ultimi anni. Ultimo controllo pneumologico: Marzo 2025, confermato quadro stabile.

- **Oculistica:**

Maculopatia degenerativa (AMD - Age-related Macular Degeneration) occhio destro diagnosticata circa 3 anni fa, forma secca (atrofica). In follow-up specialistico semestrale presso Ospedale di Imladris (Oculista: Dott. Cirdan). In trattamento con collirio multivitaminico e integratori specifici (Lutegra). Visus OD: 6/10 (con correzione lenti), OS: 10/10 (con correzione lenti). Porta occhiali da vista (presbiopia e lieve miopia). Non glaucoma.

- **Ginecologica:**

Menopausa fisiologica a 52 anni (anno 2007). Non terapia ormonale sostitutiva. Menarca a 13 anni, cicli regolari fino alla menopausa.

2 gravidanze a termine (figli nati nel 1978 e 1981), 2 parti eutocici spontanei. Nessun aborto. Allattamento al seno per entrambi i figli.

Ultimo PAP test: 2023 (negativo). Ultima mammografia: 2024 (BI-RADS 1, negativa).

- **Chirurgica:**

Nessun intervento chirurgico maggiore pregresso. Nessuna anestesia generale o loco-regionale pregressa.

Riferisce solo exeresi di nevo cutaneo benigno al dorso in anestesia locale circa 15 anni fa.

- **Osteoarticolare:**

Scoliosi degenerativa lombare destro-convessa diagnosticata circa 8 anni fa, attualmente non algica (occasionalmente lombalgia aspecifica trattata con FANS al bisogno). Non ha mai eseguito cicli di fisioterapia specifica. RX colonna lombosacrale (anno 2022): scoliosi

degenerativa lieve, discopatie L4-L5 e L5-S1 senza conflitto radicolare evidente.
Nega artrosi sintomatica di altre articolazioni.
Storia di episodi di cervicalgia tensiva sporadica (ultimo episodio circa 1 anno fa).

- **Endocrinologica:**
Nega diabete mellito, tireopatie.
Glicemia a digiuno sempre nei limiti (ultimo valore Settembre 2025: 102 mg/dL).
- **Gastroenterologica:**
Riferita gastrite sporadica, correlata principalmente all'assunzione di FANS (Ibuprofene).
Mai eseguita EGDS. Nega ulcera peptica, MRGE severo, epatopatie, calcolosi biliare.
- **Nefrologica:**
Nega IRC, calcolosi renale. Funzionalità renale sempre nei limiti (ultimo valore Creatinina 0,81 mg/dL).
- **Neurologica:**
Nega epilessia, ictus, TIA, cefalea cronica, Parkinson, demenze.
- **Psichiatrica:**
Nega depressione, ansia patologica, disturbi del sonno cronici, assunzione di psicofarmaci.

Anamnesi Familiare:

- **Padre:** deceduto all'età di 92 anni per cause naturali (insufficienza multiorgano da senilità). Aveva ipercolesterolemia.
- **Madre:** vivente, 98 anni, in buone condizioni generali per l'età, attualmente residente in casa di riposo "Rifugio della Stella" a Imladris. Autonoma nelle ADL di base.
- **Fratelli:** 1 fratello maggiore (78 anni), in buona salute, vive a Minas Tirith.
- **Figli:** 2 figli (maschio 47 anni, femmina 44 anni), entrambi in buona salute.
- **Non familiarità nota per:** patologie cardiovascolari precoci (infarto <55 anni uomini, <65 anni donne), diabete mellito, neoplasie (in particolare mammella, ovaio, colon), malattie autoimmuni, malattie neurologiche degenerative.

Anamnesi Fisiologica e Sociale:

- **Professione:** Ex insegnante di lettere classiche (Latino e Greco) presso il Liceo "Elendil" di Gran Burrone. In pensione da 5 anni (anno 2020).
- **Abitazione:** Vive con il coniuge in appartamento al secondo piano di una palazzina senza ascensore in Via Beornia 12, Gran Burrone. Riferisce che negli ultimi 6 mesi, a causa della gonalgia ingravescente al ginocchio sinistro, salire e scendere le scale quotidianamente (necessario per uscire di casa) è diventato molto difficoltoso e doloroso, limitando significativamente la sua autonomia e qualità di vita.
- **Stile di vita:** Attiva fino a circa 6 mesi fa. Abitudine a lunghe passeggiate quotidiane (5-6 km) in piano e in collina, giardinaggio, lettura. Partecipa a un club di lettura settimanale. Da circa 6 mesi, a causa del dolore al ginocchio, ha progressivamente ridotto le attività fisiche. Attualmente cammina meno di 1 km al giorno con difficoltà.
- **Fumo:** Non fumatrice, mai fumato.
- **Alcol:** Assunzione molto occasionale e modica (1 bicchiere di vino rosso ai pasti in

- occasioni sociali, meno di 1 volta/settimana). No abuso.
- **Dieta:** Segue dieta mediterranea equilibrata, attenta alla riduzione di grassi saturi e colesterolo per controllo ipercolesterolemia (evita carni rosse grasse, formaggi stagionati, consuma pesce 2-3 volte/settimana, verdure quotidianamente, olio extravergine d'oliva).
 - **Sonno:** Riferisce di dormire abitualmente 7-8 ore per notte, sonno ristoratore, non insonnia cronica. Occasionalmente, negli ultimi mesi, risveglio notturno per dolore al ginocchio se ha camminato molto durante il giorno.

Anamnesi Patologica Prossima (APP):

Paziente giunge alla nostra osservazione per gonalgia persistente e ingravescente al ginocchio sinistro insorta circa 6 mesi fa (esordio stimato: fine Aprile 2025).

- **Esordio e modalità:**
L'insorgenza è stata graduale e subdola, non a seguito di trauma distorsivo acuto o caduta evidente ricordati dalla paziente. Riferisce che il dolore è comparso per la prima volta dopo un periodo (circa 2-3 settimane prima dell'esordio sintomatologico) di camminate particolarmente intense e prolungate in collina (sentieri sterrati, lievi dislivelli) in occasione di una vacanza primaverile con il coniuge nella regione di Bosco Atro. Inizialmente il dolore era lieve, intermittente, descritto come "fastidio" localizzato alla faccia mediale del ginocchio, presente solo a fine giornata dopo lunghe camminate e tendente a risolversi con il riposo notturno.
- **Evoluzione:**
Nelle settimane successive il dolore è gradualmente peggiorato, diventando più frequente e intenso. Si è trasformato da occasionale a quasi quotidiano, scatenato da attività via via meno intense (prima lunghe camminate >3 km, poi anche camminate brevi di 500-1000 metri, infine anche salire/scendere le scale di casa).
- **Caratteristiche del dolore:**
 - **Sede:** Localizzato prevalentemente alla rima articolare mediale del ginocchio sinistro, con irradiazione occasionale alla faccia postero-mediale. Non dolore rotuleo anteriore significativo.
 - **Qualità:** Descritto dalla paziente come "trafittivo", "a spillo", "come una spina che si infila dentro quando piego il ginocchio". A volte associato a sensazione di "scatto" o "qualcosa che si muove dentro".
 - **Intensità:** Su scala VAS (0-10):
 - A riposo completo (seduta, sdraiata): VAS 1-2/10 (fastidio lieve)
 - Con carico e deambulazione in piano: VAS 4-5/10 (dopo pochi minuti)
 - Salire/scendere scale: VAS 7-8/10 (molto doloroso, limitante)
 - Accovacciamento completo: Impossibile per dolore (VAS stimata >8/10)
 - **Andamento temporale:** Dolore di tipo meccanico (peggiora con l'attività, migliora con il riposo). Quasi assente al risveglio mattutino dopo riposo notturno, aumenta progressivamente durante la giornata con le attività. Non dolore notturno significativo a riposo (solo occasionali risvegli se ha sovraccaricato durante il giorno).

- **Fattori scatenanti:** Carico, flessione del ginocchio (soprattutto tra 60-90°), movimenti di torsione (es. girarsi su se stessa mantenendo il piede fisso), scale (specialmente in discesa).
- **Fattori allevianti:** Riposo, ghiaccio locale (riferisce di applicarlo spesso la sera), gamba sollevata.
- **Limitazioni funzionali:**
 - **Deambulazione:** Limitata a meno di 1 km (prima percorreva facilmente 5-6 km senza problemi). Dopo 500-700 metri di cammino in piano comparsa di dolore significativo che la costringe a fermarsi e riposare. Ha iniziato a usare una stampella occasionalmente per lunghi tragitti (es. supermercato).
 - **Scale:** Salire e scendere le 2 rampe di scale per raggiungere la propria abitazione (circa 32 gradini totali) è diventato molto doloroso e faticoso. Impiega il doppio del tempo rispetto a prima e deve fermarsi a metà per riposare. Descende le scale "un gradino alla volta" appoggiando sempre prima la gamba destra (sana) per scaricare il peso dalla sinistra dolente.
 - **Accovacciamento:** Impossibile (es. non riesce più a inginocchiarsi per il giardinaggio, attività che amava).
 - **Attività ricreative:** Ha dovuto sospendere le passeggiate in collina, il club di escursionismo locale, il giardinaggio. Attività fortemente limitanti per la qualità di vita percepita.
- **Altri sintomi:**
 - Nega gonfiore evidente e persistente del ginocchio (riferisce solo lieve tumefazione la sera dopo giornate particolarmente faticose, che si riduce con il riposo notturno).
 - Nega arrossamento cutaneo, calore locale persistente (segni di flogosi acuta).
 - Nega cedimenti del ginocchio (giving way), sensazione di instabilità durante la deambulazione in piano.
 - Riferisce episodi saltuari (circa 3-4 volte negli ultimi 6 mesi) di "blocco" articolare incompleto in flessione: sensazione di "qualcosa che si incastra internamente" che impedisce momentaneamente il movimento fluido di flesso-estensione, accompagnato da dolore acuto. Gli episodi si sono risolti spontaneamente dopo pochi secondi/minuti con manovre di mobilitazione dolce del ginocchio (estensione e piccoli movimenti di rotazione) o cambiando posizione. Questi episodi si sono verificati principalmente durante attività come alzarsi da una sedia bassa o salire le scale. Nessun episodio di blocco completo (ginocchio "bloccato" in posizione fissa senza possibilità di movimento).
 - Nega parestesie o deficit sensitivi all'arto inferiore sinistro.
- **Iter diagnostico-terapeutico pregresso:**
 - **Maggio 2025 (circa 1 mese dopo esordio):** Prima visita dal MMG (Dott. Thranduil Verdebosco). Diagnosi clinica iniziale: "Gonalgia sinistra, sospetta lesione meniscale o condropatia". Prescritto trattamento conservativo con:
 - FANS: Ibuprofene 600mg (1 compressa ogni 8 ore dopo i pasti, al bisogno per il dolore, per max 7 giorni consecutivi). Assunto per circa 10 giorni complessivi in quel periodo. Beneficio modesto e solo temporaneo (riduzione VAS da 7 a 4-5

durante l'assunzione, ma ricomparsa del dolore alla sospensione). Riferita scarsa tolleranza gastrica: pirosi retrosternale, dolore epigastrico, nausea dopo assunzione. Successivamente utilizzato solo sporadicamente.

- Riposo relativo e applicazione locale di ghiaccio (3-4 volte al dì per 15-20 minuti).
- Consigliato uso di stampella per scaricare il ginocchio durante la deambulazione.
- **Giugno-Luglio 2025:** Persistenza della sintomatologia nonostante riposo e terapia con FANS al bisogno. Il MMG prescrive ciclo di fisioterapia.
- **Agosto-Settembre 2025:** Eseguito ciclo di 10 sedute di fisioterapia presso Centro "Le Acque Curative" di Gran Burrone (Fisioterapista: Sig.ra Eowyn). Trattamenti effettuati:
 - Tecarterapia (6 sedute) sulla regione mediale del ginocchio
 - Esercizi di rinforzo muscolare del quadricipite (isometrici ed esercizi attivi contro resistenza elastica)
 - Mobilizzazione passiva cauta del ginocchio
 - Applicazione di kinesio-tapingRiferisce miglioramento parziale della sintomatologia dolorosa durante e immediatamente dopo il ciclo (riduzione VAS media da 6-7 a 4-5), con possibilità di camminare un po' di più. Tuttavia, persistenza dei sintomi "meccanici" (blocchi saltuari, dolore vivo alla flessione profonda e sotto carico intenso come le scale). Nelle settimane successive alla sospensione della fisioterapia, graduale peggioramento e ritorno ai livelli sintomatologici precedenti.
- **15 Settembre 2025:** Su prescrizione del MMG, eseguita Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) del ginocchio sinistro presso Centro di Diagnostica "I Ponti Grigi" (vedi Sezione 6, referto completo). Referto: "Voluminosa lesione complessa a manico di secchio del menisco mediale con frammento dislocato. Condropatia femoro-rotulea di grado lieve (II)."
- **Fine Settembre 2025:** Con il referto della RMN, la paziente viene inviata dal MMG alla nostra valutazione ortopedica specialistica ambulatoriale. Prima visita ambulatoriale presso il nostro reparto effettuata il 28/09/2025 (Dott. Elrond Peredhel). Posta indicazione a intervento chirurgico artroscopico di meniscectomia selettiva, stante il fallimento della terapia conservativa, la presenza di lesione meniscale complessa con frammento dislocato e instabile (che spiega i blocchi), e la limitazione funzionale significativa con impatto importante sulla qualità di vita della paziente.
- **Ottobre 2025:** Eseguiti accertamenti pre-operatori (ECG, RX Torace, esami ematochimici, visite specialistiche - vedi Sezioni successive). Programmato ricovero per il 27/10/2025 e intervento chirurgico per il 28/10/2025.
- **Terapia Domiciliare in atto (al momento dell'ingresso in reparto, 27/10/2025):**
 - **Terapia cronica cardiovascolare/metabolica:**
 - Rosuvastatina 5 mg (1 compressa la sera dopo cena, ore 21:00 circa) - per ipercolesterolemia
 - Clopidogrel 75 mg (1 compressa al dì dopo pranzo, ore 13:00 circa) - per prevenzione eventi trombotici in paziente con carotidopatia
→ SOSPEO come da indicazione del chirurgo 5 giorni prima dell'intervento

(ultima assunzione: 22/10/2025) per ridurre il rischio emorragico peri-operatorio

○ **Terapia oculistica:**

- Collirio IDRA-ELF (principio attivo: estratto di Lacrima di Nimrodel - sostituto lacrimale con vitamine) (1 goccia nell'occhio destro, 1 volta al dì, la mattina) - per maculopatia

○ **Terapia al bisogno:**

- Cetirizina 10 mg (1 compressa al bisogno per sintomi da rinite allergica stagionale, mediamente 10-15 compresse nei mesi marzo-maggio, non assunta negli ultimi mesi)
- Ibuprofene 600 mg (1 compressa al bisogno per dolore al ginocchio, max 1-2 cp/settimana nelle ultime settimane per scarsa efficacia e pirosi gastrica)

(Firma Medico Accettante e Raccoglitore Anamnesi: Dott. Aragorn Elessar, Specializzando)

(Controfirma e Approvazione Primario: Dott. Elrond Peredhel, data 27/10/2025 ore 15:30)